



HAUTE AUTORITÉ DE SANTÉ

MESURER

& AMÉLIORER LA QUALITÉ

RAPPORT DE CERTIFICATION

APHM-HOPITAL NORD

Chemin des bourrely
13915 Marseille



Validé par la HAS en Juin 2024

Ce document ainsi que sa référence bibliographique sont téléchargeables sur www.has-sante.fr



Haute Autorité de santé – Service communication et information
5 avenue du Stade de France – 93218 SAINT-DENIS LA PLAINE CEDEX. Tél. : +33 (0)1 55 93 70 00
© Haute Autorité de santé – Juin 2024

Sommaire

Préambule	4
Décision	7
Présentation	8
Champs d'applicabilité	9
Résultats	10
Chapitre 1 : Le patient	11
Chapitre 2 : Les équipes de soins	14
Chapitre 3 : L'établissement	18
Table des Annexes	22
Annexe 1. Liste des établissements géographiques rattachées à la démarche	23
Annexe 2. Synthèse des activités réalisées par l'établissement en 2024	24
Annexe 3. Programme de visite	28

Préambule

La certification, mission confiée à la Haute Autorité de Santé (HAS) par les ordonnances de 1996, est une procédure d'évaluation externe des établissements de santé publics et privés effectuée par des professionnels (des pairs) mandatés par la HAS : les experts-visiteurs. Cette procédure quadri-annuelle, indépendante de l'établissement et de ses organismes de tutelle, porte sur le niveau de qualité et de sécurité des soins délivrés aux patients. Obligatoire, elle est codifiée à l'article L6113-3 (et suivants) du code de la santé publique.

La certification constitue une des modalités de mesure de la qualité des soins en établissements de santé et vise l'appropriation des standards de la qualité par les établissements. Elle y favorise également la mise en œuvre d'une dynamique d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Elle est une certification globale et non une certification de toutes les activités de l'établissement. En effet, le dispositif porte sur le fonctionnement global de l'établissement et n'a pas vocation à évaluer spécifiquement le fonctionnement de chaque secteur d'activité.

Elle fournit une évaluation de la qualité et de la sécurité des soins des établissements de santé aux usagers et aux Agences régionales de santé (ARS) sans se substituer aux inspections et contrôles de sécurité sanitaire menés par ces autorités de tutelle.

Cette démarche nationale est réalisée selon des standards internationaux : la procédure de certification est elle-même évaluée par l'International Society for Quality in Health Care via l'International Accreditation Program (IAP), le seul programme international qui accrédite les organismes qui accréditent des structures de soins. La HAS a obtenu de l'ISQua en 2018 le renouvellement de son accréditation pour son activité de certification.

Une évaluation qui s'appuie sur un référentiel élaboré par la HAS en concertation avec les professionnels de santé, les organisations représentatives et les représentants des usagers...

Chaque établissement de santé est évalué sur les critères génériques, s'appliquant à tout l'établissement, ainsi que sur des critères spécifiques relevant :

- de populations spécifiques : enfant et adolescent, patient âgé, personne en situation de handicap,
- de modes de prise en charge spécifiques : ambulatoire, hospitalisation à domicile (HAD), SAMU-SMUR, urgences, soins critiques (soins continus, soins intensifs et réanimation)
- de secteurs d'activités spécifiques : chirurgie et interventionnel, maternité, psychiatrie et santé mentale, soins médicaux et de réadaptation (SMR), unité de soins de longue durée (USLD).

Ce référentiel, publié sur le site Internet de la HAS, comprend des critères ayant des niveaux d'exigence différents :

- des critères standards correspondent aux attendus de la certification;
- des critères impératifs correspondent à ce que l'on ne veut plus voir au sein d'un établissement de santé. Ils ont un impact particulier dans la décision de certification. En effet, si une évaluation de l'un de ces critères est négative pour un ou plusieurs de ses éléments d'évaluation, la HAS se réserve le droit de ne pas accorder la certification de l'établissement.
- des critères avancés correspondent à des exigences souhaitées mais non exigibles à ce jour. Ils correspondent potentiellement aux critères de certification de demain et sont valorisés pour les établissements qui peuvent y répondre sous condition d'un niveau minimal sur l'ensemble des critères standards et impératifs.

| ... et sur des méthodes

- des patients traceurs pour évaluer la qualité et la sécurité de la prise en charge d'un patient dans l'établissement de santé
- des parcours traceurs pour évaluer la continuité et la coordination de la prise en charge des patients, le travail en équipe et la culture qualité et sécurité au cours d'un parcours de soins défini
- des traceurs ciblés pour évaluer la mise en œuvre d'un processus ciblé
- des audits systèmes pour évaluer les organisations de l'établissement et s'assurer de leur maîtrise sur le terrain
- des observations pour évaluer les conditions générales de qualité et de sécurité des soins.

| Un rapport de certification structuré en 3 chapitres

Les résultats des évaluations réalisées durant une visite de l'établissement par des experts-visiteurs se traduisent dans un rapport de visite articulé en cohérence avec les 3 chapitres du référentiel.:

- Le premier chapitre concerne directement le résultat pour le patient. Tout au long de sa prise en charge, ses droits sont respectés, ses besoins spécifiques pris en compte de la même façon que ses attentes et ses préférences. Au-delà, l'engagement du patient est recherché. Son implication comme partenaire de sa prise en charge, tout comme celle de ses proches et aidants, est favorisée par l'expression de son point de vue sur son expérience et le résultat des soins.
- Le deuxième chapitre concerne les équipes de soins, à tous les niveaux. La certification vise à apprécier leur capacité à rechercher la pertinence, l'efficacité et la sécurité des soins, à se concerter et se coordonner tout au long du parcours du patient. Elle met également l'accent sur la maîtrise des risques liés au soin. Les analyses des événements indésirables associés aux soins, notamment les événements indésirables graves ainsi que des rapports de certification précédents conduisent à mettre un accent particulier sur le risque infectieux et le risque lié aux médicaments.
- Le troisième chapitre concerne l'établissement et sa gouvernance (direction et commission/conférence médicale d'établissement). Cette dernière favorise l'insertion territoriale en lien avec les autres acteurs de l'offre de soins et médico-sociale. Elle impulse une dynamique forte d'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins qui associe et soutient les équipes, ainsi que les patients, représentants d'usagers et associations de malades.

Cette structuration permet l'analyse croisée entre le résultat pour le patient, les pratiques mises en œuvre par les équipes de soins et la dynamique impulsée par la gouvernance de l'établissement et du groupement, le cas échéant.

| Une décision et un rapport rendus publics

Sur la base du rapport de visite, complété d'éventuelles fiches d'anomalies et des observations de l'établissement, la HAS adopte le rapport de certification et rend une décision. La HAS peut prononcer trois types de décision :

- une décision de certification valable quatre ans qu'elle peut assortir d'une mention ;
- une décision de non-certification impliquant la mise en œuvre d'une nouvelle procédure dans un délai maximum de deux ans ;
- une décision de certification sous conditions ; une nouvelle procédure est alors programmée dans un délai compris entre six et douze mois. À l'issue de cette seconde procédure, la HAS constate si l'établissement a rempli les conditions pour être certifié. Elle prononce alors une décision de certification, avec ou sans mention, ou une décision de non-certification.

Le rapport et la décision sont publiés sur le site Internet de la HAS et communiqués à l'autorité de tutelle de l'établissement.

L'établissement doit en assurer la plus large diffusion interne. Il doit notamment la porter à la connaissance des instances délibérantes, de la commission ou conférence médicale d'établissement et de la commission des usagers.

Ce rapport de visite est produit par l'équipe des experts-visiteurs dans un délai d'une quinzaine de jour après la fin des évaluations et de la réunion de restitution, il est transmis à l'établissement pour que celui-ci puisse formuler ses observations. Il sera remis également à la HAS et fera partie des éléments de référence pour l'élaboration du rapport de certification

Décision

Au vu des éléments mentionnés dans le présent rapport, issus de la visite sur site, la Haute Autorité de santé décide la certification de l'établissement avec mention.

Présentation

APHM-HOPITAL NORD	
Adresse	Chemin des bourrely 13915 Marseille FRANCE
Département / Région	Bouches-du-Rhône / Provence-Alpes-Côte d'Azur
Statut	Public
Type d'établissement	Centre Hospitalier Universitaire

Établissement(s) juridique(s) rattaché(s) à cette démarche (la liste des établissements géographiques se trouve en annexe 1)

Type de structure	N° FINESS	Nom de l'établissement	Adresse
Établissement juridique	130786049	ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE	80 rue brochier 13005 Marseille 05eme FRANCE

Synthèse des activités réalisées par l'établissement au 2024

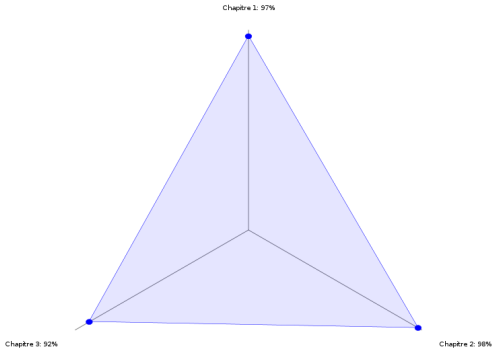
Vous trouverez en annexe 2 l'ensemble des activités réalisées par l'établissement.

Champs d'applicabilité

Champs d'applicabilité
Adulte
Ambulatoire
Chirurgie et interventionnel
Enfant et adolescent
Hospitalisation complète
Maladie chronique
Maternité
Médecine
Pas de situation particulière
Patient âgé
Patient atteint d'un cancer
Patient en situation de handicap
Patient en situation de précarité
Programmé
Psychiatrie et santé mentale
SAMU-SMUR
Soins critiques
Soins Médicaux et de Réadaptation
Tout l'établissement
Urgences

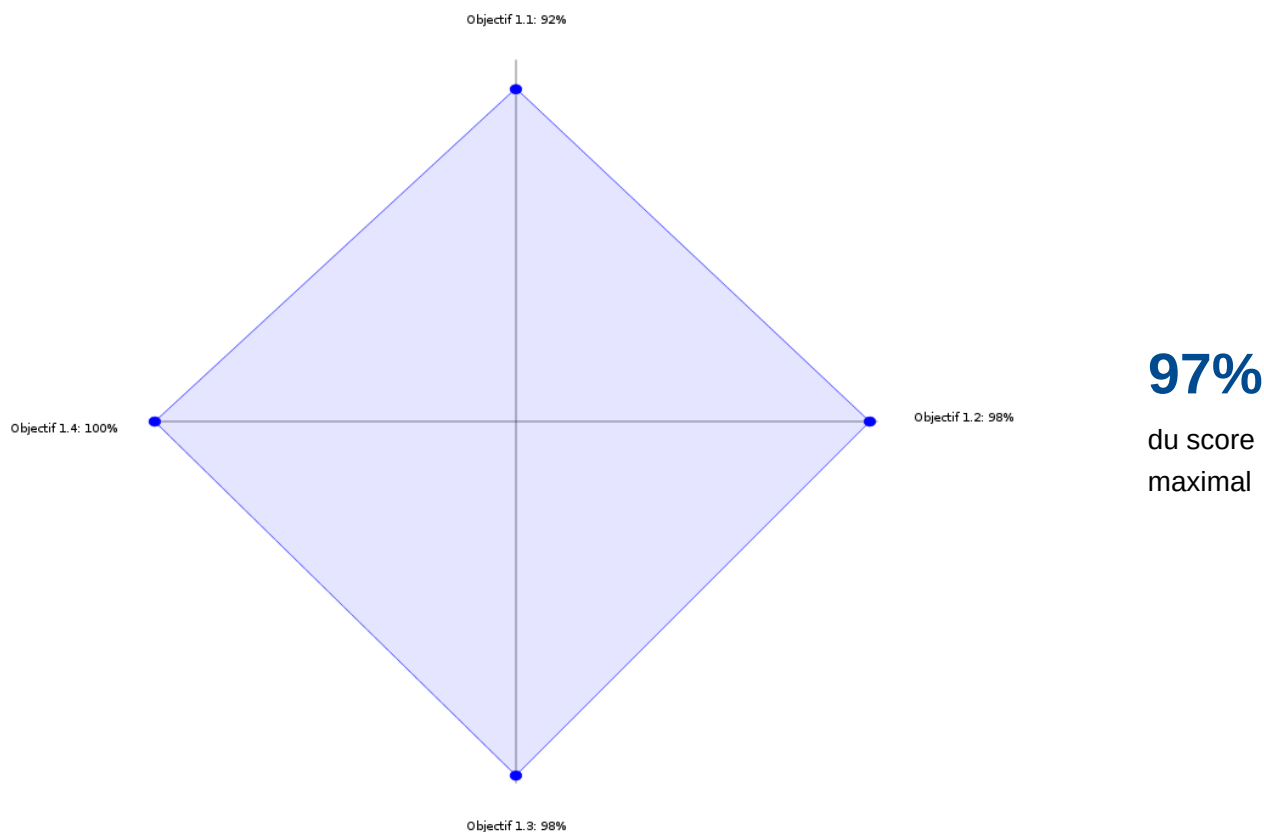
Au regard du profil de l'établissement, [126](#) critères lui sont applicables

Résultats



Chapitre	
Chapitre 1	Le patient
Chapitre 2	Les équipes de soins
Chapitre 3	L'établissement

Chapitre 1 : Le patient



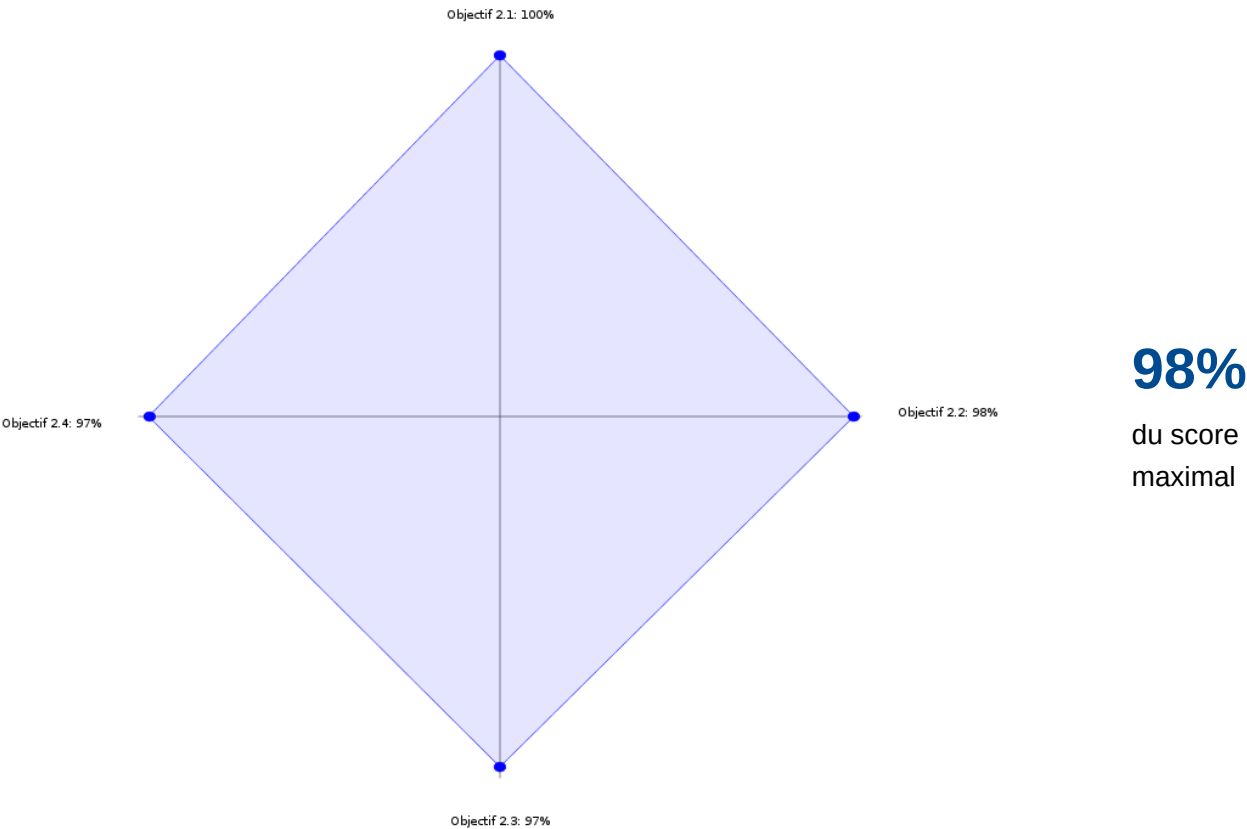
Objectifs		
1.1	Le patient est informé et son implication est recherchée.	92%
1.2	Le patient est respecté.	98%
1.3	Les proches et/ou aidants sont associés à la mise en œuvre du projet de soins avec l'accord du patient	98%
1.4	Les conditions de vie et de lien social du patient sont prises en compte dans le cadre de sa prise en charge	100%

Le patient reçoit une information claire, adaptée à son degré de discernement sur son état de santé, ses soins et les hypothèses et confirmations diagnostiques ; les supports d'information sont nombreux et accessibles et les patients rencontrés témoignent des informations fournies sans qu'ils le demandent par les différents professionnels les prenant en charge, avec les explications utiles pour le déroulé de leur parcours (exemples : parcours RACC en chirurgie, parcours greffe de poumon, parcours de la future maman, tableau blanc en réanimation néonatalogie permettant aux parents et aux soignants de noter des informations, photos pour montrer au patient les soins qui vont lui être prodigués en oncologie) ; cependant ils ne sont pas toujours informés du délai de leur prise en charge. Le patient exprime son consentement libre et éclairé sur son projet de soins et ses modalités (évaluation bénéfice/risque partagée, préférences du patient recherchée). L'enfant ou

l'adolescent est invité à exprimer son avis sur le projet de soins ; par exemple, en chirurgie pédiatrique, l'intervention est expliquée à l'enfant en capacité de comprendre avec moyens pour faciliter sa compréhension (doudou, masque d'anesthésie avec des images, tableau ludique, voitures téléguidées). Le patient bénéficie de messages renforçant sa capacité à agir pour sa santé ; de nombreux supports d'information et de communication sous des formes diverses de messages de santé publique, accompagnées de propositions de consultations spécialisées (addictologie, sexologie par exemple) ou de programme d'éducation thérapeutique. Le patient bénéficie d'actions pour devenir acteur de sa prise en charge (exemples : proposition de visite du service en amont en néonatalogie, information avant la naissance sur l'allaitement). Les futurs parents discutent d'un projet de naissance avec l'équipe soignante dès le début de la grossesse. Le patient peut désigner la personne à prévenir et la personne de confiance de son choix. Le patient, en prévision de sa sortie, est informé des consignes de suivi pour sa prise en charge. Le patient est informé des dispositifs médicaux qui lui sont implantés durant son séjour et reçoit les consignes de suivi appropriées (feuille de surveillance des DMI aux blocs opératoires, numéro DMI scanné et carte d'implant remise au patient). Le patient est informé des produits sanguins labiles qui lui sont administrés (courrier d'information pré et post transfusion avec ordonnance de RAI). En ambulatoire, le patient reçoit les informations spécifiques aux modalités de sa prise en charge (exemples : passeport ambulatoire, film disponible sur le site internet du CHU sur l'organisation de l'unité de chirurgie ambulatoire, appel à J-3 et J-3 de l'IDE). Si l'établissement a prévu de tracer les directives anticipées dans le dossier du patient et a mis à disposition de celui-ci des documents d'information et une explication dans le livret d'accueil, certains patients rencontrés disent ne pas être informés de leur droit à rédiger des directives anticipées ; Le patient a la possibilité, en situation de fin de vie, de faire valoir au plus tôt sa décision d'accéder aux soins palliatifs. Le patient est informé sur les représentants des usagers et les associations de bénévoles qui peuvent l'accompagner pour son retour à domicile ; pour autant les patients rencontrés lors de la visite ne connaissent pas toujours les coordonnées des représentants des usagers ni les structures qui peuvent l'accompagner à son retour à domicile. Le patient est invité à faire part de son expérience et à exprimer sa satisfaction. En plus d'e-satis, le CHU a mis en place de nombreux questionnaires spécifiques de satisfaction L'expérience patient est recueillie sous différentes modalités, par exemple la mise en place d'un film « parents avant l'heure » explicitant la prise en charge des parents, ou encore un questionnaire spécifique en orthopédie de retour d'expérience patient pour le levé précoce en salle de SSPI par le kinésithérapeute RAC. Pour autant la plupart des patients rencontrés expriment le fait de ne pas être informés des modalités pour exprimer leur satisfaction, soumettre une réclamation ou déclarer un évènement indésirable associé aux soins. Le patient reçoit une information claire et adaptée à son degré de discernement sur les modalités de sa prise en charge (livrets d'accueil spécifiques dans de nombreux services, consignes pré, per et post hospitalisations) ; néanmoins le patient ne sait pas toujours que l'équipe alimente et consulte son DMP et qu'il ne doit pas échanger avec l'équipe via une messagerie non sécurisée et ce malgré les informations fournis par l'établissement dans le livret d'accueil et affichages. Le patient bénéficie du respect de son intimité et de sa dignité (matériels type paravents dans les chambres à deux lits, en SSPI ou aux urgences, journée du silence pour sensibiliser les soignants eu respect d'un environnement calme en néonatalogie). Cependant si les pratiques respectueuses sont partout constatées, certains locaux ou bâtiments anciens ne facilitent pas toujours le respect de ses droit (exemples : peu de toilettes et douches dans certains services, notamment dans le secteur de médecine, exigüité des locaux aux urgences adultes) ; le projet architectural est mis en œuvre progressivement notamment avec l'ouverture en 2027 d'un nouveau bâtiment cardio vasculaire et en 2030 la fin des opérations de rénovation du bâtiment principal. Le patient mineur bénéficie d'un environnement adapté locaux spécifiques aux urgences, en SSPI, en unité de chirurgie ambulatoire, formations des professionnels à la communication spécifique, matériels adaptés). Le patient vivant avec un handicap bénéficie du maintien de son autonomie tout au long de son séjour, de même que le patient âgé (réhabilitation très précoce favorisée dès la SSPI avec intervention des kinésithérapeutes, ergothérapeutes et ostéopathes, évaluation de l'autonomie dès l'entrée en médecine interne). Le patient bénéficie du respect de la confidentialité des informations le concernant. Le recours à la contention mécanique relève d'une décision

médicale argumentée, expliquée au patient quand cela s'avère possible, réévaluation, contention limitée dans le temps en HUSI). Le patient reçoit une aide pour ses besoins élémentaires, même en situation de tension d'activité. Le patient bénéficie de soins visant à anticiper et soulager rapidement sa douleur (nombreuses échelles utilisées et adaptées, prescriptions y compris les « si besoin » complètes, réévaluation régulière, formations des professionnels, méthodes douces de prise en charge type hypnoanalgésie ou à l'hypnose conversationnelle, apprentissage des parents pour reconnaître les signes de douleur en néonatalogie). Avec l'accord du patient les proches et/ou aidants peuvent s'impliquer dans la mise en œuvre du projet de soins ; par exemple un livret d'accueil est à disposition des familles de la personne hospitalisée en médecine interne et réanimation et un temps dédié est réservé quotidiennement à l'information des proches. La présence des proches et aidants est facilitée en dehors des heures de visite lorsque la situation l'exige et selon des modalités adaptées aux services (salon des familles, horaires souples, voire accueil 24h/24 comme en USIC, agent d'accueil en réanimation polyvalente, présence facilitée des parents en SSPI, mise à disposition de studios pour l'hébergement des proches avec un réseau également d'hospitalité chez l'habitant. Les conditions de vie et de lien social du patient sont partout prises en compte dans le cadre de sa prise en charge. Le patient en situation de précarité sociale bénéficie d'un accompagnement pour une orientation vers les services sociaux et associations adéquates (repérage de la précarité aux urgences adultes et pédiatriques, staffs médico-psycho-social hebdomadaire dans de nombreux services, présence d'IDEC dans tous les services favorisant les liens avec les services adéquats extérieurs, liens avec armée du salut, service social de secteur, PMI, etc). Le patient vivant avec un handicap ou ses proches et aidants exprime ses besoins et préférences pour une prise en compte dans son projet de soins. Le patient mineur atteint d'une maladie chronique ou vivant avec un handicap bénéficie de modalités de prise en charge intégrant les préoccupations sociales ; éducatives et scolaires adaptées à la situation exemple : présence d'un professionnel de l'Education Nationale pour la prise en charge scolaire des enfants si besoin). Le patient détenu atteint de troubles psychiques bénéficie d'un panel de soins et d'activités adaptés et diversifiés avec accompagnement personnalisé en UHSA. Les conditions de vie habituelles sont prises en compte notamment pour la préparation de la sortie (exemple en néonatalogie évaluation des conditions de vie et accompagnement des familles à la sortie de l'hospitalisation du prématuré, équipe mobile dans les quartiers défavorisés).

Chapitre 2 : Les équipes de soins



Objectifs		
2.1	La pertinence des parcours, des actes et des prescriptions est argumentée au sein de l'équipe	100%
2.2	Les équipes sont coordonnées pour prendre en charge le patient de manière pluriprofessionnelle et pluridisciplinaire tout au long de sa prise en charge	98%
2.3	Les équipes maîtrisent les risques liés à leurs pratiques	97%
2.4	Les équipes évaluent leurs pratiques notamment au regard du suivi des résultats cliniques de leur patientèle	97%

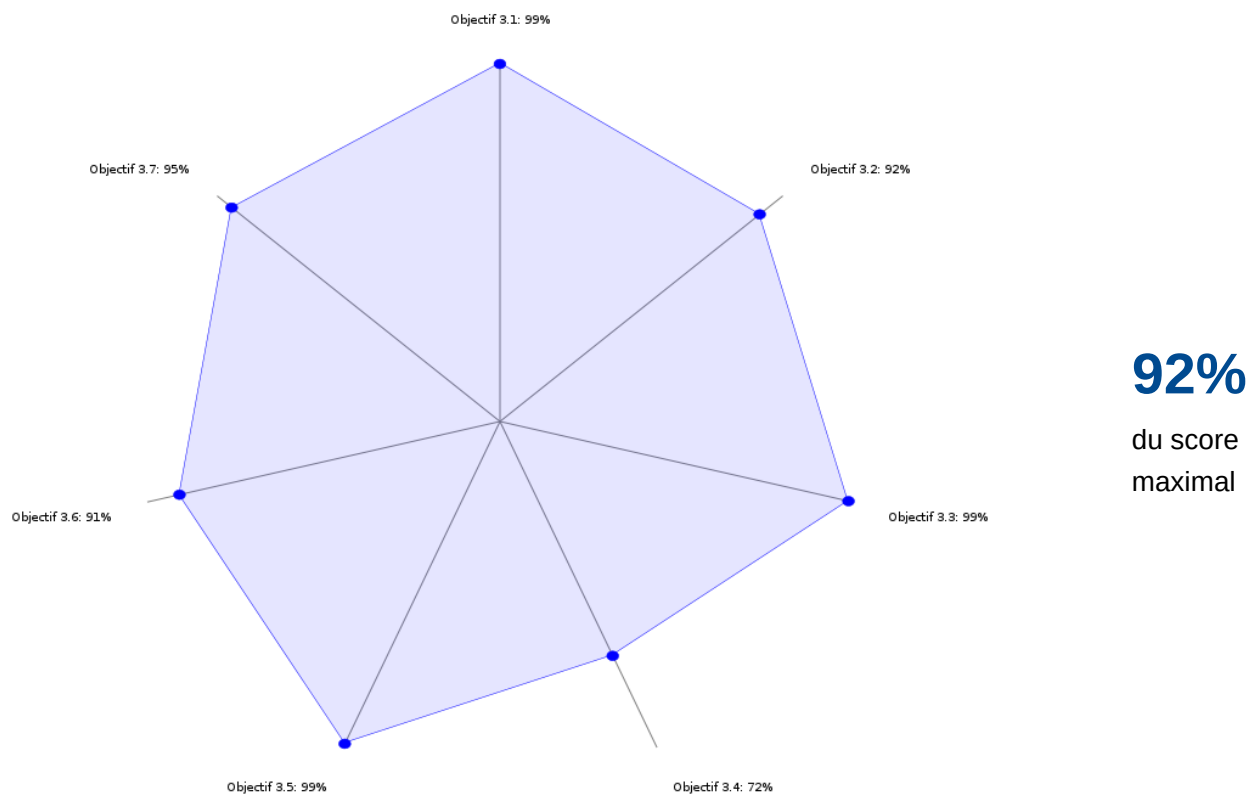
La pertinence des décisions de prise en charge est argumentée au sein des équipes (nombreuses RCP pour des prise en charges spécifiques ou complexes, en chirurgie bariatrique par exemple). La pertinence de l'orientation du patient par le SAMU de l'APHM et le SMUR de l'hôpital Nord est argumentée avec les équipes d'aval. La pertinence de l'admission et du séjour en SMR est argumentée et réévaluée au sein des équipes. En hospitalisation traditionnelle, la prescription d'une HAD (soit celle de l'APHM, soit celles d'établissements privés) est envisagée dans le cadre du projet de soins dès l'admission du patient. La pertinence du recours à des mesures restrictives de liberté est argumenté et réévaluée. La pertinence des prescriptions d'antibiotiques est argumentée et réévaluée (nombreux protocoles, formations des prescripteurs, référents interne ou externe antibiothérapie, audits réguliers sur les prescriptions et la consommation, logo apparaissant sur le DPI pour

attirer l'attention sur la nécessité de réévaluer à 48h et appel du pharmacien si besoin, staffs infectieux en chirurgie, orthopédique). La pertinence de la transfusion des produits sanguins labiles est argumentée (analyse bénéfice risque tracée, évaluation régulière de la pertinence des transfusions). Le dossier médical préhospitalier des SMUR comporte tous les éléments nécessaires à la poursuite de la prise en charge du patient (dossier disponible en temps réel aux urgences adultes et pédiatriques). Les équipes des urgences assurent au patient une orientation dans les circuits et délais adaptés à sa prise en charge, avec des circuits courts pour les réanimations, l'USIC, l'UNV. Les équipes de soins ont accès aux informations du patient avec un système d'information adapté ; pour autant les équipes rencontrées ne consultent pas le DMP du patient. Il a été constaté des liens étroits entre services des urgences et services des soins pour que le patient puisse dès que possible bénéficier d'une chambre dans le service adéquat (consultations rapides des cliniciens aux urgences) Les équipes se coordonnent pour la mise en œuvre du projet de soin (staffs dans tous les services et pour tous les parcours, type chirurgie thoracique, bariatrique, transplantations, projet de soins construit de façon collégiale en associant si besoin les professionnels de soins de support, possibilité de téléconsultation en chirurgie bariatrique, en dermatologie, en anesthésie, équipes mobiles très actives et disponibles en douleur, soins palliatifs, gériatrie). La sécurité de la prise en charge médicamenteuse du patient bénéficie d'une conciliation des traitements médicamenteux conciliation pharmaceutique à l'admission et à la sortie pour la médecine interne et la gériatrie, conciliation à l'admission en HDJ gériatrique et pour les patients polymédicamentés ayant une intervention chirurgicale thoracique). Les équipes se coordonnent dans le cas où le patient n'a pas été orienté dans l'unité adaptée faute de disponibilité. L'équipe de soins peut faire appel si besoin à un réseau d'équipes de recours ou d'expertise (exemple : appel à une équipe recours de néphrologie de la Timone, recours interne possible en infectiologie, douleur, etc). Les acteurs de la programmation opératoire se coordonnent et tiennent compte de la priorisation des urgences (charte des blocs respectées, programmation tenant compte de l'âge, du handicap éventuel, analyse des écarts de programmation et reprogrammations dans un délai court). Les secteurs interventionnels et les secteurs des soins échangent très majoritairement toutes les informations relatives au patient. Aux blocs et dans les secteurs interventionnels, la check List « sécurité du patient » est utilisée de manière efficace (check List adaptée à chaque plateau interventionnel). En phase de transition adolescent-adulte, les équipes se coordonnent pour assurer la continuité de la prise en charge du patient. Le carnet de santé, le dossier du patient et le cas échéant le dossier médical de mon espace santé sont mis à jour de manière synchronisée pour assurer la continuité des soins. Les équipes réalisent un examen somatique dans les 24h suivant l'admission pour tout patient hospitalisé en psychiatrie (UHSA). Dans l'UHSA, la prise en charge, les critères d'alerte sont évalués à l'aide d'outils partagés. Une démarche palliative pluridisciplinaire, pluriprofessionnelle et coordonnée est mise en œuvre pour les patients en fin de vie. Une lettre de liaison à la sortie est remise au patient et permet la continuité du parcours de soins ; le traitement d'entrée et de sortie est très majoritairement précisé dans la lettre de liaison ; une ordonnance de sortie est systématiquement donnée. La maîtrise des risques est une priorité de l'APHM, déclinée à l'hôpital Nord. Les équipes respectent les bonnes pratiques d'identification du patient à toutes les étapes de la prise en charge avec dispositif d'identification adapté (exemples : pour le nouveau-né sur le berceau, photo sur le livre de rendez-vous et sur la console de traitement en radiothérapie). Les équipes maîtrisent la mise en application des vigilances sanitaires. En ce qui concerne les médicaments, il existe un classeur dans chaque unité rappelant toute la procédure générale d'organisation de l'approvisionnement et de la permanence pharmaceutique (spécificité de l'hôpital Nord). Les équipes respectent les bonnes pratiques de prescription et de dispensation des médicaments (prescription complète informatisée y compris pour les « si besoin », dispensation sécurisée et adaptée aux services, analyse pharmaceutique de niveau 3, dispensation nominative globalisée pour plus de 500 lis sur 3 jours et dispensation nominative journalière pour les autres services type UHSI) ; cependant l'analyse pharmaceutique n'intègre pas les informations du dossier pharmaceutique du patient pour tous les patients qui en sont dotés. Elles respectent également les bonnes pratiques d'administration (exemple : étiquetage des médicaments injectables reconstitués, traçabilité de l'administration au plus près du patient, vérification des contre-indications à certaines pratiques de broyage).

Elles maîtrisent l'utilisation des médicaments à risque (liste personnalisée pour chaque service avec travail collaboratif sur la liste à utiliser, identification dans les armoires à pharmacie, sensibilisation et formation des professionnels, chambre des erreurs, escape Game. L'approvisionnement, le stockage et l'accès aux produits de santé sont réalisés conformément aux recommandations de bonnes pratiques (exemple : traçabilité dématérialisée à partir de la pharmacie pour les DMI, conditions de transport sécurisés pour tous les produits de santé avec QR code, stockage spécifique du KCL). De nombreuses évaluations du circuit du médicament ont lieu régulièrement. Les équipes maîtrisent le risque de discontinuité de la prise en charge médicamenteuse du patient vulnérable à sa sortie ; pour autant le bilan thérapeutique n'est pas systématiquement retrouvé dans la lettre de liaison. Les équipes maîtrisent la sécurité transfusionnelle (traçabilité complète de la prescription, de l'administration, de la surveillance et des événements indésirables, taux de destruction suivi). Toutes les équipes maîtrisent le risque infectieux en appliquant les bonnes pratiques d'hygiène des mains, (exemple : en chirurgie thoracique, EPP sur l'hygiène des mains, sensibilisation très régulière des professionnels, voire des parents comme en réanimation néonatale avec l'appui de l'EOH, audits ou auto évaluation avec rendu trimestriel de la consommation de solution hydro alcoolique par secteur). Elles maîtrisent également le risque infectieux en appliquant les précautions adéquates, standard et complémentaires (patients informés très majoritairement, parents systématiquement informés, prescriptions des isolements complètes). Les équipes maîtrisent les bonnes pratiques d'antibioprophylaxie liés aux actes invasifs (prescription dès la consultation préanesthésique, confirmée en visite préopératoire et prescrite le matin de l'acte chirurgical, respect du délai induction/incision, audits réguliers). Les équipes maîtrisent le risque infectieux lié au circuit des dispositifs médicaux invasifs (maîtrise de la gestion des endoscopes, locaux conformes, EPI correctement utilisés, contrôles et suivis des endoscopes partagés avec prélèvements réalisés en binôme IDE/AS traçabilité complète de la vie de l'endoscope et numéro de l'endoscope retrouvé le dossier patient). Elles maîtrisent le risque infectieux lié aux dispositifs médicaux invasifs en appliquant les précautions adéquates (préparation cutanée tracée dans le dossier patient par exemple, suivi de la bactériémie sur les cathéters, prélèvement systématique hebdomadaire au niveau des sondages urinaires et VNI). Les équipes des secteurs interventionnels maîtrisent le risque infectieux en respectant les bonnes pratiques per opératoires (audits et EPP dans tous les secteurs concernés à l'exception du bloc gynécologique, service dans lequel les EPP arrêtées en 2020 vont reprendre cette année). Les équipes pluriprofessionnelles maîtrisent le risque de dépendance iatrogène. Les équipes respectent les recommandations et obligations vaccinales pour les professionnels de santé. La gestion des récurrences d'épisodes de violence est anticipée et gérée avec le patient à l'aide d'un plan de prévention partagé (UHSA et UHSI). Les équipes maîtrisent les risques liés à l'utilisation de rayonnements ionisants. Les équipes maîtrisent les risques liés à l'hémorragie du post partum immédiat (chariot dédié, kit embolie amniotique, feuille de surveillance spécifique, suivi d'indicateurs. L'autorisation de sortie du patient en chirurgie ambulatoire est validée (score de Chung ou donnée par le chirurgien). Le transport des patients en intra hospitalier est maîtrisé (conditions de sécurité et de confort du patient respectées, matériels adaptés, professionnels formés au respect des droits des patients et aux gestes d'urgence, régulation opérationnelle avec logiciel, patients majoritairement informés du délai de prise en charge). Les équipes améliorent leurs pratiques en se fondant sur l'analyse de leurs résultats cliniques (nombreuses démarches d'évaluation clinique sur des parcours type chirurgie de l'obésité, évaluation du dispositif « patient debout » pour se rendre au bloc opératoire ou sur des modalités de prise en charge la douleur par exemple aux urgences). Elles améliorent leurs pratiques en se fondant sur la satisfaction et l'expérience de leurs patients (exemples : utilisation de l'expérience patient pendant les ateliers thérapeutiques, recueil de l'expérience patient sur la qualité de vie a posteriori de l'acte chirurgical, utilisation de l'expérience patient pour la rénovation du hall d'accueil et salle d'attente des urgences générales adultes, animation de groupes de paroles, analyse de verbatims e-satis, café des usagers organisé par les représentants des usagers). Elles améliorent leurs pratiques en se fondant sur leurs résultats d'indicateurs notamment des indicateurs qualité et sécurité des soins (tableau de bord qualité/sécurité des soins médical et paramédical par service des indicateurs nationaux et spécifiques). Les équipes améliorent leurs pratiques en analysant les

événements indésirables associées aux soins qu'elles ont déclarés (déclaration faite sur le logiciel APMH et sur le portail de déclaration ARS, nombreux CREX et RMM avec utilisation d'une méthode d'analyse avérée). Les équipes des secteurs de soins critiques améliorent leurs pratiques en se fondant notamment sur les modalités de prise en charge de leurs patients (exemple évaluation des soins de support utilisés en radiothérapie, en pneumologie interventionnelle ou en chirurgie digestive pour les patients colectomisés et pris en charge dans le parcours RAAC, registres de refus d'admission) ; cependant elles suivent peu les ré hospitalisations à 48/72 heures. Les équipes des secteurs interventionnels améliorent leurs pratiques en analysant les modalités de réalisation de la check List (audit annuel sur l'ensemble des chirurgies et blocs, suivi des GO/no GO). Des actions d'amélioration de la qualité des résultats des examens de biologie médicale et d'anatomopathologie sont mises en place (non conformités visibles par les prescripteurs, analyse en commun, délais de rendu des résultats suivis et contractualisés, prestation de conseils des biologistes auprès des cliniciens). Des actions d'amélioration de la qualité des résultats des examens d'imagerie médicale sont également mises en place (conditions de réalisation des examens conformes aux référentiels de bonnes pratiques, évaluation de la pertinence des prescriptions de scanner et d'IRM, délais de rendez-vous adaptés, participation des imageurs à toutes les RCP de l'établissement). Les nombreuses activités de prélèvement et de greffes d'organes et de tissus sont évaluées régulièrement et se traduisent par des plans d'actions d'amélioration dont les effets sont mesurés.

Chapitre 3 : L'établissement



Objectifs		
3.1	L'établissement définit ses orientations stratégiques en cohérence avec son territoire	99%
3.2	L'établissement favorise l'engagement des patients individuellement et collectivement	92%
3.3	La gouvernance fait preuve de leadership	99%
3.4	L'établissement favorise le travail en équipe et le développement des compétences	72%
3.5	Les professionnels sont impliqués dans une démarche de qualité de vie au travail impulsée par la gouvernance	99%
3.6	L'établissement dispose d'une réponse adaptée et opérationnelle aux risques auxquels il peut être confronté	91%
3.7	L'établissement développe une dynamique d'amélioration continue de la qualité des soins	95%

L'APHM est l'établissement pivot du système de santé régional. IL se compose de quatre sites (hôpital de la Timone, hôpital Nord, hôpital Conception et hôpital Sud), 25 pôles d'activités médicales et 250 services (au total 3300 lits et places), 93 centres labellisés Maladies rares, un centre d'enseignement et de recherche avec l'Institut Méditerranée Universitaire (infectiologie) et trois centres de recherche hospitalo-universitaires, 13

instituts de formation, 3 centres de santé (Aygaldes, Flamants et Aubagne), une maison des femmes à Marseille. L'APHM est établissement support du GHT 13 et été en 2023 à l'initiative d'un projet stratégique de territoire, avec la mise en œuvre des postes partagés en médecine et en chirurgie pour favoriser le développement de filières et conforter son attractivité, le développement d'une filière gériatrique avec les établissements médico-sociaux. L'établissement a également tissé des liens avec les cliniques et la médecine de ville. Il est le premier employeur de la région PACA avec 3000 professionnels médicaux et 13000 professionnels non médicaux. La stratégie en politique de santé, en politique des ressources humaines, en implication des représentants des usagers et en maîtrise des risques est élaborée au niveau central et déclinée sur chaque site. En ce qui concerne l'hôpital Nord, l'offre de soins se caractérise par des activités d'urgences adultes, gynécologiques et enfants, la majorité des spécialités médicales et chirurgicales, dont certaines s'occupant de maladies rares, de gynécologie-obstétrique, et complétée par une UHSA et une UHSI ; le plateau technique est composé de l'imagerie, d'un service de médecine nucléaire (temporairement fermée pour cause de travaux), de 30 salles de blocs, d'un service de radiothérapie, de salles d'endoscopie digestive et thoracique, d'une cardiologie interventionnelle et de 5 salles de naissance avec un bloc césarienne. Le projet immobilier de l'APHM CAP 2030 se décline sur l'hôpital Nord avec l'ouverture en 2024 du nouveau service de médecine nucléaire, des réanimations en 2025, d'un bâtiment cardio-vasculaire en 2027 et d'une rénovation complète du bâtiment historique à grande hauteur en 2030. L'hôpital Nord de par sa situation géographique a notamment tissé des liens avec ses partenaires du nord du département et de la région en déclinant la politique institutionnelle de l'APHM. Il participe à toutes les filières définies au niveau de l'APHM et coordonne plusieurs parcours (exemple : chirurgie bariatrique, chirurgie thoracique, greffe poumon, etc) ; il partage des postes avec d'autres centres hospitaliers, active des équipes sur La Timone (exemple : cellule de régulation périnatale). Il met en place des organisations avec la médecine de ville (maison médicale de garde aux urgences, participation aux travaux des CPTS) ; il travaille avec des partenaires sur des populations spécifiques (exemple : travail avec l'URIOPSS pour les patients vivant avec un handicap). Il participe à la dynamique de projet territorial de santé mentale et collabore avec les services ambulatoires de psychiatrie ; deux équipes de liaison médicale et para médicale (adulte et pédopsychiatrie) sont disponibles aux urgences, dans les services de soins et dans les secteurs réservés aux détenus (UHSA et UHSI). L'hôpital Nord draine une population socialement en difficulté, vulnérable et en grande précarité ; il a de ce fait développer des organisations pour prendre en charge ces populations (aide à la parentalité, IPA dans le pôle thorax et aux urgences adultes) pour faire le lien avec l'extérieur. Des modalités de prise en charge rapide sont en place pour les admissions en urgence dans les unités spécialisées ; La filière personnes âgées est déclinée en conventions avec les établissements médico-sociaux et un accès direct en gériatrie, y compris en HDJ, est organisé avec les médecins de ville (IDE de gériatrie aux urgences). Les modalités de communication permettent aux usagers de contacter aisément l'établissement. Une messagerie sécurisée concerne un nombre croissant de médecins généralistes. Un quart de l'activité de recherche clinique de l'APHM est concentrée à l'hôpital Nord avec des publications spécifiques (thorax, cardiologie, gynécologie-obstétrique par exemple) ; l'activité de recherche paramédicale se développe également (néonatalogie par exemple). L'établissement promeut toutes formes de recueil de l'expression du patient ; en plus d'e-satis, de nombreux questionnaires spécifiques sont à disposition des usagers. Des PREMS et des PROMS sont mis en œuvre dans plusieurs services (exemple : PROMS en chirurgie bariatrique, en sclérodermie, pour les inflammations d'intestin). Il mobilise les actions d'expertise des patients : patient expert dans plusieurs services (exemple : chirurgie digestive), parents partenaires en néonatalogie avec un « café des parents », film « parole de parents » en néonatalogie, journal de bord en réanimation polyvalente, mesure de l'expérience patient en USIC ayant abouti à revoir l'organisation du service pour diminuer le bruit ambiant, patient ressource dans le cadre de plusieurs programmes d'éducation thérapeutique (sclérodermie par exemple). Les représentants des usagers participent aux CREX institutionnels. Toutefois, l'impact des intégrations de l'expertise des patients n'est pas évalué ; par ailleurs la participation des patients à des démarches collectives d'amélioration des pratiques reste modérée. L'établissement a une communication centrée sur le patient (nombreuses formations proposées aux

professionnels, type formation à l'écoute active et passive). Il veille à la bientraitance et met en œuvre des pratiques adaptées à la patientèle (exemple en maternité ; respect du rythme du nouveau-né) et participe au repérage et à la prise en charge des maltraitances éventuelles subies par les patients (exemple : sensibilisation et formations aux urgences pédiatriques aux différentes formes de maltraitance dont les mutilations sexuelles, fiche réflexe en UCA et en maternité pour le repérage des violences faites aux femmes). Il lutte contre la maltraitance en son sein. Compte tenu de l'architecture ancienne, de la configuration de certains bâtiments et locaux, des accès extérieurs parfois difficiles, l'accessibilité des locaux aux personnes vivant avec un handicap n'est pas facilitée malgré les aménagements faits pour les personnes vivant avec un handicap moteur notamment. L'établissement favorise l'accès aux soins des personnes vulnérables (dispositifs nombreux : service social, interprètes, services spécialisés, PASS, dotation d'antalgiques et de produits contraceptifs dédiée aux populations en grande précarité). Il est organisé pour permettre au patient d'accéder à son dossier. Il favorise l'accès aux innovations pour les patients. Il implique les représentants des usagers et les associations de patients en son sein, dans les instances (CDU locale très active, présence des RU dans les instances spécialisées -CLUD, Comité qualité/sécurité des soins, etc- et à et groupes de travail) et dans la vie de l'établissement. Il a rédigé avec les représentants des usagers et diffusé une charte d'inclusion des usagers en mars 2024 ; les représentants des usagers ont entamé des visites de services avec une fiche à destination des patients sortants qu'ils rencontrent ; pour autant, le projet des usagers 2023-2026 n'est pas complètement articulé avec le projet médico-soignant en cours de réécriture. La gouvernance fonde son management sur la qualité et la sécurité des soins. Impulsée par la gouvernance institutionnelle de l'APHM et par celle de l'hôpital Nord, la qualité et sécurité sont intégrées comme préoccupation majeure dans les instances et dans les pôles et services ; le PAQSS complet est décliné au plus près des équipes avec une implication forte de la direction qualité de l'APHM et du site. L'établissement soutient une culture de sécurité des soins (enquête régulière culture sécurité, 16 services « labellisés » culture sécurité des soins). La gouvernance pilote l'adéquation entre les ressources humaines disponibles et la qualité et la sécurité des prises en charge (pool IDE/AS dans les services de soins critiques et sur certains pôles plus fragiles, dispositif Hublo, cellule de programmation et de régulation au bloc, accompagnement des nouveaux arrivants médicaux et non médicaux, mise en place de compagnonnage postes de travail adapté avec contrat individuel, réorientation sur l'heure des patients arrivés aux urgences vers la Timone en cas de difficulté et de tension) . Les responsables d'équipe bénéficient de formations ou de coaching en management (formation initiale des chefs de pôle et de service, programme d'accompagnement à la prise de fonction, coaching des faisant fonction de cadre de santé). La gouvernance impulse et soutient le travail en équipe ; de nombreuses possibilités sont offertes pour faciliter le travail en équipe : désignation d'IDE major pour assurer entre autres les audits et les actions qualité en équipe, réunions de service à 19h00 pour favoriser la présence des professionnels de nuit, démarches de mutualisation d'activités, par exemple au bloc central, prime d'engagement collectif, staffs pluri-services, RCP dans de nombreuses disciplines, consultations réalisées avec plusieurs spécialistes type pédiatrie/secteur adulte pour l'asthme sévère, etc. La gouvernance impulse et soutient des démarches spécifiques d'amélioration du travail en équipe ; des équipes médicales sont accréditées (exemples : chirurgie thoracique, radiologie interventionnelle, à venir la gastro-entérologie). Les connaissances et les compétences individuelles et collectives des équipes sont assurées (exemple : parcours d'évaluation protocolisé des connaissances pour le nouveau soignant en réanimation néonatale, promotion de la formation par simulation en maternité, formations à des D.U) ; l'entretien individuel annuel des praticiens n'est cependant pas mis en place (calendrier de déploiement validé par la direction générale et la présidence de CME avec réalisation des entretiens de mai à septembre 2024). L'établissement promeut et soutient le recours au questionnement éthique par l'ensemble des acteurs ; des compétences internes sont accessibles (soins palliatifs par exemple), des compétences externes également au sein de l'APHM ; des avis et une aide de psychologue sont mis en œuvre ; une fiche LATA est utilisée par les équipes ; des staffs sont organisés ; pour autant il n'y a pas d'état des lieux des questionnements éthiques réalisé, pas de cadre opérationnel permettant la prise en compte rapide des problématiques éthiques, type comité éthique (projet en cours au niveau de l'APHM) à l'exception de quelques

secteurs de soins critiques qui se sont organisés ; les représentants des usagers ne sont donc pas de ce fait associés à la réflexion éthique. La gouvernance a une politique de qualité de vie au travail, en déclinant la politique institutionnelle de l'APHM (réfèrent QVT et groupe de travail, politique d'accueil et de formation des professionnels, tutorat, mentorat, réfèrent planning pour prendre en compte les impératifs des professionnels, groupes de travail sur les changements de l'organisation du travail, salle de détente, etc). La gouvernance met en place des mesures de gestion des difficultés interpersonnelles et des conflits (dispositif de médiation, apport de psychologue du travail, formation gestion des conflits ; la majorité des professionnels connaissent les dispositifs extérieurs existants. La gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles est maîtrisée (participation à des exercices type AMAVI en 2023, centre de formation pour les risques NRBC, plan blanc actualisé). La prévention des atteintes aux personnes et aux biens est assurée ; le plan de sécurisation est à jour et comporte de nombreux dispositifs de prévention et de gestion des situations de d'intrusion, de violence ou d'agressivité (portes sécurisées, dispositif d'appel direct du service des urgences au commissariat, agents d'accueil aux urgences et en réanimation pour diminuer l'agressivité, formation à la communication non violente, règles de sécurité connues des professionnels, etc) ; trois services sur cinquante sont encore à sécuriser complètement en accès entrant et sortant. Les risques environnementaux et les enjeux du développement durable sont maîtrisés : réfèrent et groupe de travail dédié, actions sur l'éco-conception des soins au bloc opératoire, actions autour du soin sur le tri des déchets et à leur revalorisation, label éco-conception des soins en cours en maternité, projet GREEN en réanimation, formation des encadrants). La prise en charge des urgences vitales est maîtrisée dans l'enceinte de l'établissement (numéro d'appel unique dédié, uniformisation des chariots et sacs facilement accessibles, formation des professionnels à l'AFGSU en fonction de leur affectation (professionnels de nuit, isolés, etc) ; les exercices de simulation in situ commencent à être mise en œuvre. L'identification des utilisateurs et des patients dans le système d'information est sécurisée. La gouvernance mobilise ses équipes dans la maîtrise des bonnes pratiques (implication des instances, participation des équipes à l'élaboration de protocoles) ; cependant les revues de pertinence des admissions et des séjours ne sont pas partout développées. L'établissement prend en compte le point de vue du patient dans son programme d'amélioration de la qualité avec une participation active dans la CDU, les groupes de travail et le COPIL qualité/risques ; néanmoins les équipes connaissent peu les recommandations établies par la CDU. L'établissement analyse, exploite et communique les indicateurs qualité et sécurité des soins : participation de professionnels au recueil des indicateurs, suivi d'indicateurs hors protocole par trimestre (dossier de soins par exemple), tableau de bord IQSS médical et non médical dans tous les services, flash infos). Il analyse, exploite et communique également la survenue d'événements indésirables liés aux soins (nombreux RMM et CREX). L'établissement améliore l'organisation de l'aval des urgences pour assurer un parcours intra hospitalier de qualité en toute sécurité (IDEC dans les services, situation des lits analysés très régulièrement). L'accréditation des médecins et des équipes médicales est promue dans l'établissement (médecins accrédités dans de nombreuses disciplines, deux équipes accréditées).

Table des Annexes

- Annexe 1. Liste des établissements géographiques rattachées à la démarche
- Annexe 2. Synthèse des activités réalisées par l'établissement en 2024
- Annexe 3. Programme de visite

Annexe 1. Liste des établissements géographiques rattachées à la démarche

Type de structure	N° FINESS	Nom de l'établissement	Adresse
Établissement juridique	130786049	ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE	80 rue brochier 13005 Marseille 05eme FRANCE
Établissement principal	130780521	APHM-HOPITAL NORD	Chemin des bourrely 13915 Marseille FRANCE

Annexe 2. Synthèse des activités réalisées par l'établissement en 2024

Catégorie / Champs d'applicabilité / Donnée de profil	Valeur
Autorisations	
Urgences	
Existence d'un soignant d'accueil et d'orientation	Oui
Si oui, l'accueil et l'orientation sont réalisés par IAO (infirmière d'accueil et d'orientation) ou par MAO (médecin d'accueil et d'orientation)	Oui
Existence de Structure des urgences générales	Oui
Existence de Structure des urgences pédiatriques	Oui
Hospitalisation à domicile	
Présence d'une astreinte opérationnelle soignante H24 et 7/7 (IDE se déplaçant au domicile)	Non
Autorisation de Médecine en HAD	Non
Autorisation d' Obstétrique en HAD	Non
Autorisation de SMR en HAD	Non
Autorisation de Prise en charge du cancer en HAD	Non
Tout l'établissement	
Existence d'une permanence d'accès aux soins de santé (PASS) dans votre établissement	Oui
Existence d'une solution d'informatisation du circuit du médicament à la PUI	Oui
Existence d'Unité de préparation des médicaments de chimiothérapie anticancéreuse	Oui
SAMU-SMUR	
Existence de SMUR général	Non
Existence de SMUR pédiatrique	Non
Existence d'Antenne SMUR	Oui
Existence d'un SAMU	Non
Soins critiques	
Présence de service de Réanimation (y compris soins intensifs et surveillance continue)	Oui
Présence de Réanimation enfant (hors néonatalogie)	Oui

Présence d'Unité de soins intensifs en cardiologie (USIC)	Oui
Présence d'Unité de surveillance continue (SC) adulte	Oui
Présence d'Unité de surveillance continue (SC) enfant	Oui
Médecine	
Autorisation de Traitement de l'insuffisance rénale chronique (hors péritonéale) en centre	Non
Autorisation de Traitement de l'insuffisance rénale chronique (péritonéale)	Non
Patient atteint d'un cancer	
Autorisation de Traitement des affections cancéreuses par chimiothérapie	Oui
Autorisation de Traitement des affections cancéreuses par radiothérapie (dont curiethérapie)	Oui
Chirurgie et interventionnel	
Autorisation de Chirurgie cardiaque	Non
Autorisation d'Activité interventionnelle en cardiologie	Oui
Autorisation de Neurochirurgie	Oui
Autorisation d'Activité interventionnelle en neurologie	Non
Autorisation d'Activité de greffe	Oui
Activité Urgences	
Urgences	
Nombre total de passages aux urgences dans l'année pour des patients de plus de 80 ans	5,544
Nombre de passages aux urgences générales	65,195
Nombre de passages aux urgences pédiatriques	36,510
SAMU-SMUR	
Nombre de Dossiers de Régulation Médicale (DRM)	0
Activité Hospitalière MCO	
Soins de longue durée	
Nombre de patients PEC durant l'année écoulée par une équipe mobile de gériatrie	0
Médecine	
Nombre de lit en Hospitalisation complète en Médecine	441
Chirurgie et interventionnel	

Nombre de lit en Hospitalisation complète en Chirurgie	202
Maternité	
Nombre de lit en Hospitalisation complète en Gynécologie-Obstétrique	57
Ambulatoire	
Nombre de places en Hospitalisation partielle en Médecine	42
Nombre de places en Hospitalisation partielle en Chirurgie	35
Nombre de places en hospitalisation partielle en Gynécologie-Obstétrique	14
Tout l'établissement	
Nombre de séances en hospitalisation partielle en Médecine	27,088
Enfant et adolescent	
Nombre de lit en Hospitalisation complète en Pédiatrie	38
Nombre de places en Hospitalisation partielle en Pédiatrie	10
Patient âgé	
Nombre de lit en Hospitalisation complète en Gériatrie	25
Nombre de places en Hospitalisation partielle en Gériatrie	2
Urgences	
Nombre de lit en UHCD	13
Activité Hospitalière SMR	
Soins Médicaux et de Réadaptation	
Nombre de lit en Hospitalisation complète en SMR	6
Nombre de places en Hospitalisation partielle en SMR	0
Activité Hospitalière SLD	
Soins de longue durée	
Nombre de lit en Hospitalisation complète en SLD	0
Activité Accident Vasculaires Cérébraux (AVC)	
Chirurgie et interventionnel	
Nombre de lits de l'Unité Neuro-Vasculaire (UNV)	0
Activité Hospitalière PSY	
Psychiatrie et santé mentale	
Nombre de lit en Psychiatrie générale en hospitalisation à temps plein	0

Nombre de lit en Psychiatrie infanto-juvénile en hospitalisation à temps plein	0
Nombre de lit en Psychiatrie en milieu pénitentiaire en hospitalisation à temps plein	40
Nombre Total de lit en Psychiatrie en hospitalisation à temps plein	40
Nombre de lit en Psychiatrie générale en hospitalisation de jour	0
Nombre de lit en Psychiatrie infanto-juvénile en hospitalisation de jour	0
Nombre de lit en Psychiatrie en milieu pénitentiaire en hospitalisation de jour	0
Nombre Total de lit en Psychiatrie en hospitalisation de jour	0
Nombre de CATTP en Psychiatrie générale	0
Nombre de CATTP en Psychiatrie infanto-juvénile	0
Nombre de CATTP en Psychiatrie en milieu pénitentiaire	0
Nombre Total de CATTP en Psychiatrie	0
Nombre de CMP en Psychiatrie générale	0
Nombre de CMP en Psychiatrie infanto-juvénile	0
Nombre Total de CMP en Psychiatrie	0
Sites opératoires et salles d'intervention	
Chirurgie et interventionnel	
Nombre total de salles (d'intervention ou d'exploration) des sites (calculé)	34
Ambulatoire	
Nombre de salles dédiées à la chirurgie ambulatoire	0
Activité Hospitalière HAD	
Hospitalisation à domicile	
Nombre total de patients pouvant être pris en charge simultanément en HAD	0

Annexe 3. Programme de visite

Nb	Méthode	Sous-méthode	Champs d'applicabilité	Description traceur
1	Traceur ciblé			EIGS déclarés SMR A HDJ et HC
2	Parcours traceur		Chirurgie et interventionnel Soins Médicaux et de Réadaptation Hospitalisation complète Adulte Pas de situation particulière Programmé Tout l'établissement	
3	Audit système			
4	Audit système			
5	Traceur ciblé			Prescription d'un patient intégrant, a minima, un Antibiotique per os ou injectable
6	Patient traceur		Médecine Hospitalisation complète Patient âgé Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
7	Patient traceur		Médecine Hospitalisation complète Enfant et adolescent Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	

8	Patient traceur		Maternité Hospitalisation complète Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
9	Patient traceur		Chirurgie et interventionnel Ambulatoire Enfant et adolescent Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
10	Patient traceur		Médecine Hospitalisation complète Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
11	Patient traceur		Médecine Hospitalisation complète Enfant et adolescent Patient en situation de handicap Urgences Tout l'établissement	
12	Patient traceur		Médecine Hospitalisation complète Patient âgé Patient en situation de handicap Urgences Tout l'établissement	

13	Patient traceur		Chirurgie et interventionnel Ambulatoire Patient âgé Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
14	Patient traceur		Chirurgie et interventionnel Hospitalisation complète Patient âgé Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
15	Patient traceur		Médecine Hospitalisation complète Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
16	Patient traceur		Soins critiques Hospitalisation complète Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
17	Parcours traceur		Soins critiques Hospitalisation complète Adulte Patient âgé Patient en situation de handicap Urgences Tout l'établissement	
	Patient		Chirurgie et interventionnel	

18	traceur		Ambulatoire Patient âgé Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
19	Parcours traceur		Médecine Hospitalisation complète Enfant et adolescent Patient en situation de handicap Urgences Tout l'établissement	
20	Traceur ciblé			SAMU SMUR
21	Traceur ciblé			Antibioprophylaxie et Per opératoire
22	Traceur ciblé			Prescription d'un patient intégrant, a minima, un Médicament à risque injectable
23	Traceur ciblé			Précautions standard et complémentaires
24	Traceur ciblé			Antibioprophylaxie et Per opératoire
25	Traceur ciblé			Prescription d'un patient intégrant, a minima, un Médicament à risque per os
26	Traceur ciblé			chimiothérapie
27	Audit système			
28	Audit système			
29	Audit système			
30	Audit système			

31	Audit système			
32	Audit système			
33	Parcours traceur		Chirurgie et interventionnel Ambulatoire Enfant et adolescent Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
34	Parcours traceur		Chirurgie et interventionnel Médecine Ambulatoire Hospitalisation complète Adulte Patient âgé Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
35	Patient traceur		Médecine Ambulatoire Patient âgé Patient atteint d'un cancer Programmé Tout l'établissement	
36	Audit système			
37	Audit système			
38	Audit système			
39	Traceur ciblé			Précautions standard et complémentaires

40	Traceur ciblé			Prescription d'un patient intégrant, a minima, un Antibiotique per os ou injectable
41	Patient traceur		Médecine Hospitalisation complète Adulte Patient atteint d'un cancer Urgences Tout l'établissement	
42	Patient traceur		Médecine Hospitalisation complète Adulte Patient atteint d'un cancer Programmé Tout l'établissement	
43	Patient traceur		Soins Médicaux et de Réadaptation Hospitalisation complète Patient âgé Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
44	Patient traceur		Psychiatrie et santé mentale Hospitalisation complète Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
45	Traceur ciblé			PSL
46	Traceur ciblé			EI selon liste transmise par l'établissmeent

47	Patient traceur		Soins critiques Hospitalisation complète Enfant et adolescent Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
48	Patient traceur		Chirurgie et interventionnel Hospitalisation complète Patient âgé Patient en situation de handicap Urgences Tout l'établissement	
49	Patient traceur		Médecine Hospitalisation complète Adulte Maladie chronique Programmé Tout l'établissement	
50	Patient traceur		Médecine Hospitalisation complète Patient âgé Patient en situation de handicap Urgences Tout l'établissement	
51	Patient traceur		Maternité Hospitalisation complète Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	

52	Patient traceur		Soins critiques Hospitalisation complète Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
53	Parcours traceur		Chirurgie et interventionnel Ambulatoire Adulte Patient âgé Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
54	Patient traceur		Chirurgie et interventionnel Hospitalisation complète Patient âgé Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
55	Parcours traceur		Soins critiques Hospitalisation complète Adulte Patient âgé Patient en situation de handicap SAMU-SMUR Urgences Tout l'établissement	
56	Audit système			

57	Parcours traceur		Chirurgie et interventionnel Soins Médicaux et de Réadaptation Hospitalisation complète Adulte Patient âgé Patient en situation de handicap Urgences Tout l'établissement	
58	Parcours traceur		Chirurgie et interventionnel Médecine Ambulatoire Hospitalisation complète Adulte Patient âgé Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
59	Patient traceur		Chirurgie et interventionnel Hospitalisation complète Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
60	Parcours traceur		Psychiatrie et santé mentale Hospitalisation complète Adulte Patient âgé Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
61	Audit système			

62	Traceur ciblé			Dispositif médical réutilisable (Endoscope)
63	Parcours traceur		Médecine Soins critiques Hospitalisation complète Adulte Patient âgé Patient en situation de handicap SAMU-SMUR Tout l'établissement	
64	Traceur ciblé			Prescription d'un patient intégrant, a minima, un Antibiotique per os ou injectable
65	Parcours traceur		Chirurgie et interventionnel Maternité Hospitalisation complète Adulte Patient en situation de handicap Urgences Tout l'établissement	
66	Audit système			
67	Audit système			
68	Patient traceur		Chirurgie et interventionnel Ambulatoire Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	

69	Parcours traceur		Chirurgie et interventionnel Médecine Hospitalisation complète Adulte Patient âgé Patient en situation de handicap Urgences Tout l'établissement	
70	Patient traceur		Médecine Hospitalisation complète Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
71	Parcours traceur		Médecine Hospitalisation complète Adulte Patient âgé Patient en situation de handicap Urgences Tout l'établissement	
72	Patient traceur		Médecine Hospitalisation complète Adulte Patient en situation de handicap Programmé Tout l'établissement	
73	Audit système			
74	Audit système			
75	Audit système			

Retrouvez tous nos travaux sur
www.has-sante.fr

